

Rò Trực Tràng-Niệu Đạo (ở Nam giới)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Đường thông bất thường giữa trực tràng và niệu đạo

Rò trực tràng-niệu đạo là một đường thông bất thường (một đường hầm nhỏ) giữa **trực tràng** (ruột cuối) và **niệu đạo** (ống dẫn nước tiểu). Nó có thể khiến nước tiểu chảy vào trực tràng và khí hoặc phân lọt vào nước tiểu, gây nhiễm trùng tái phát. Tình trạng này gây khó chịu, nhưng có thể sửa chữa được — thường theo phương pháp nhiều giai đoạn có kế hoạch.

Về tình trạng này

Triệu chứng thường gặp: **khí hoặc phân trong nước tiểu** (bong bóng khi đi tiểu, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi), **nước tiểu rò ra từ trực tràng**, nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát và khó chịu vùng chậu. Đây là vấn đề về cấu trúc cơ thể với giải pháp phẫu thuật — không phải lỗi của bạn.

Nguyên nhân

Phần lớn rò trực tràng-niệu đạo là **biến chứng của điều trị ung thư tuyến tiền liệt** — phẫu thuật (cắt bỏ tuyến tiền liệt), **xạ trị**, hoặc triệt tiêu khối u (như áp lạnh hoặc HIFU) — hoặc sau phẫu thuật trực tràng. Ít gặp hơn, nguyên nhân có thể là chấn thương, nhiễm trùng, hoặc viêm ruột mạn tính. Rò sau **xạ trị** thường phức tạp hơn để lành.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Đường rò (fistula)

Đường thông bất thường nối hai cơ quan.

Trực tràng-niệu đạo

Giữa trực tràng và niệu đạo.

Pneumaturia

Khí/bong bóng trong nước tiểu.

Fecaluria

Phân trong nước tiểu.

Chuyển lưu (Diversion)

Tạm thời dẫn nước tiểu và/hoặc phân ra ngoài để vết thương lành.

Colostomy

Lỗ mở tạm thời dẫn phân ra ngoài, có thể đóng lại sau này.

Vật cơ gracilis

Vật cơ đùi thường dùng để gia cố vùng sửa chữa.

TẠI SAO TÔI CÓ THỂ CẦN STOMA HOẶC ỐNG THÔNG TẠM THỜI TRƯỚC? Chuyển lưu nước tiểu (qua ống thông hoặc ống dẫn) và đôi khi phân (qua colostomy tạm thời) giúp giảm áp lực lên vùng tổn thương, kiểm soát nhiễm trùng và để mô viêm hồi phục — tạo điều kiện tốt nhất cho ca phẫu thuật sửa chữa sau này lành lại. Các biện pháp chuyển lưu này thường là **tạm thời** và được đóng lại sau khi lành.

Chẩn đoán như thế nào

- Nội soi bàng quang/niệu đạo (**cystoscopy**) và nội soi trực tràng
- **Kiểm tra thuốc nhuộm** và chẩn đoán hình ảnh để xác định kích thước và vị trí đường rò
- Xem xét tiền sử bệnh (điều trị ung thư tuyến tiền liệt, xạ trị) và chất lượng mô

Điều trị như thế nào

- 1 **Ổn định và chuyển lưu** — đặt ống thông (và đôi khi colostomy tạm thời) để kiểm soát triệu chứng và giúp mô hồi phục.
- 2 **Phẫu thuật sửa chữa** — thường qua vùng giữa bìu và hậu môn (đường tầng sinh môn), đóng đường rò nhiều lớp.
- 3 **Vạt mô** — cơ khỏe mạnh (thường là vạt cơ **gracilis** từ đùi) được đặt giữa hai vùng sửa chữa, đặc biệt sau xạ trị.
- 4 **Phục hồi** — các stoma tạm thời được đóng lại sau khi xác nhận lành thương.

Điều cần biết

- Thời điểm quan trọng — bác sĩ thường chờ tình trạng viêm lắng xuống trước khi phẫu thuật.
- Rò nhỏ chưa qua xạ trị đôi khi tự lành chỉ với ống thông.
- Dinh dưỡng tốt và không hút thuốc giúp vết thương mau lành.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Sốt, ớn lạnh hoặc cảm thấy rất khó chịu** (có thể nhiễm trùng nặng)
- Đau vùng chậu hoặc trực tràng dữ dội
- **Không đi tiểu được** hoặc chảy máu nhiều

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Rò trực tràng-niệu đạo nổi trực tràng và niệu đạo — gây khí/phân trong nước tiểu và nhiễm trùng — thường xảy ra sau điều trị ung thư tuyến tiền liệt.
2. Điều trị thường nhiều giai đoạn: chuyển lưu và ổn định trước, rồi phẫu thuật sửa chữa (thường kèm vạt mô, nhất là sau xạ trị), sau đó đóng stoma tạm thời.
3. Tình trạng này có thể sửa chữa được. Hãy đến gặp bác sĩ ngay nếu bạn bị sốt, đau nặng hoặc không đi tiểu được.